

Fecha Última Actualización: 28-07-2022 13:35:31

Página 1 de 2

Información Paciente

Nombre : Juan Eduardo Sepulveda Barriga
Edad : 75a 1m 26d
Dirección : Lordacion 382 El Tranque

Rut : 5.651.780-4
Fecha Nacto: 02/06/1947
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : A500991
Sexo : Masculino
Teléfono : 2 2401 5318

N° Epicrisis
316801

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 09/07/2022 20:19

Días Estadía: 19

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 28/07/2022 13:07

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Disnea progresiva

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

JUAN EDUARDO SEPULVEDA BARRIGA
RUT 5.651.780-4
75 años
F. INGRESO HSR 09.07
F. INGRESO UCI 14.07

Diagnósticos actuales:

1. Infección de tracto sanguíneo
· Imipenem (7)+ Vancomicina (7) (FI 21.07.22)
2. Hematuria macroscópica
3. Insuficiencia respiratoria aguda
· Neumonía multifocal en tto
· Ampicilina/Sulbactam (9) + Azitromicina (7) suspendidos el 21.07.22
4. Leucemia mielode aguda: Manejo paliativo.
5. Bicitopenia (anemia / plaquetopenia)
6. Insuficiencia Renal Aguda
7. Antecedentes: HTA, TBC ganglionar con tto completo 2018, TBQ suspendido

Motivo de consulta:

Disnea progresiva 2 semanas (hospitalización domiciliaria), tos + expectoración mucopurulenta.

Enfermedad actual:

Paciente cursando hospitalización en HSR desde el 09.07 por insuficiencia ventilatoria secundaria a NAC con sospecha de TBC, bicitopenia + posible LLA e IRA prerrenal.

Evolución por sistemas:

Hemodinamia: al ingreso cursando shock séptico de foco pulmonar, con requerimientos de NAD hasta 0.26 mcg/kg/min. Luego de reanimación y manejo del shock, sin requerimientos de DVA.

Respiratorio: insuficiencia respiratoria aguda en contexto de neumonía multifocal; se mantuvo con con CNAF FiO2 55%, con

Fecha Epicrisis : 28/07/2022 13:35

Página 1 de 2

Fecha Última Actualización: 28-07-2022 13:35:31

Página 2 de 2

mala respuesta, evolucionando con SDRA y requiriendo VMI el 13.07. AngioTAC de Tx de ingreso descarta TEP y al control del 12.07 muestra importante progresión de las condensaciones múltiples. Se inicia BNM entre el 14.07 y 18.07. Posteriormente con PaFi estables en 150-180 por lo que no se logra progresar en weaning.

Infeccioso: ingresa por neumonía multifocal, con antecedente de TBC ganglionar en 2018. BK I y II (-), Genexpert (-). Evaluado por equipo de infectología, se sugirió no iniciar tto TBC hasta confirmación dg y agregar azitromicina a ampicilina/sulbactam por gravedad. PCR covid (-), Panel viral (-). Se realiza LBA pero muestras son rechazadas por laboratorio; se difiere nueva muestra por inestabilidad de paciente. El día 21.07 presenta peak febril, por lo que se pancultiva y se inicia Imipenem + Vancomicina; se rescata HC que muestra S. epidermidis; completa 7 días de esquema biasociado.

Hematológico: paciente evaluado por hematología, probable leucemia linfoblástica aguda vs LLC con infiltración medular. Frotis realizado el 09.07.22: Restos de Gumprecht++, 1% linfocitos hiperbasófilos, 88% blastos de tamaño mediano, cromatina laxa, presencia de 1 a 3 nucleolos, núcleo de forma irregular con escaso citoplasma hiperbasófilo". Se tramita Citometría con inmunoserotipo y PCR traslocación BCR ABL que confirman diagnóstico de Leucemia Mieloide Aguda. Equipo de hematología indica que paciente se encuentra fuera de alcance terapéutico, por lo que se indica cuidados paliativo. Durante la hospitalización presenta múltiples gatillos transfusionales, recibiendo GR y plaquetas en varias ocasiones; posteriormente por progresión de paciente, se decide manejo proporcional y no reiniciar transfusiones.

Urológico: evoluciona con hematuria macroscópica muy abundante y con coágulos. Evaluado por urología y dado pronóstico de paciente difieren intervención quirúrgica. Se mantiene con sonda de 3 lúmenes e irrigación vesical continua, logrando control de sangrado sólo por 2 días.

Renal: desde el ingreso con injuria renal aguda sin criterios de HD de urgencia. Con rápida progresión en los últimos días. No candidato a TRR por pronóstico.

Hidroelectrolítico: Presenta hipernatremia que se resuelve con agua libre. En relación a falla renal aguda, cursa con hiperkalemia, sin arritmias en monitor. Se intenta medidas shift sin respuesta.

Fallece el 28.07.22 a las 10:25 am. Se informa a familia.

Diagnóstico de Egreso

Leucemia Mieloide aguda -
LEUCEMIA MIELOBLÁSTICA AGUDA [LMA] -

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Fallecido

Plan Post Alta

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

Marcela Alejandra Alvarado Prieto
Becado/Residente



Simon De La Maza Fontecilla
Médico Tratante (Staff)

INTERNO
Fecha Epicrisis : 28/07/2022 13:35

Página 2 de 2